

Dermatopatología — Guía de estudio

Dermatitis liquenoide y de interfase

Capítulo 7

Apuntes originales en español, redactados como material de estudio. No sustituyen al atlas ni a la observación directa de las preparaciones.

Índice

Para actualizar el índice en Word: clic derecho sobre él → «Actualizar campos». También puedes navegar con el Panel de navegación (Vista → Panel de navegación).

Capítulo 7 — Dermatitis liquenoide y de interfase

El término "liquenoide" designa dermatosis inflamatorias caracterizadas por un infiltrado linfohistiocitario "en banda" en la dermis superficial, que se adosa a la unión dermoepidérmica y a menudo la oculta. El liquen plano es el prototipo. "De interfase" se refiere a la presencia de vacuolización de las células basales (degeneración hidrópica) y suele acompañarse de apoptosis de queratinocitos aislados (cuerpos de Civatte/coloides).

Ambos términos no son mutuamente excluyentes: casi todos los infiltrados liquenoides muestran cambios de interfase, y muchas dermatosis de interfase tienen algún infiltrado liquenoide. Sin embargo, algunas dermatosis se definen sobre todo por el cambio de interfase con escaso infiltrado en banda, como el lupus eritematoso y el eritema multiforme. Una dicotomía práctica distingue el patrón de interfase "vacuolar" (escaso infiltrado, queratinocitos apoptóticos dispersos; p. ej., eritema multiforme, EICH agudo, lupus agudo) del patrón de interfase "liquenoide" (infiltrado en banda denso; p. ej., liquen plano, lupus crónico, erupciones liquenoides por fármacos).

Pistas para afinar el diagnóstico: la forma de la apoptosis y su localización (basal en el liquen plano; en todos los niveles y masiva en el eritema multiforme/NET), la presencia de hipergranulosis en cuña y crestas "en dientes de sierra" (liquen plano), la paraqueratosis (excluye liquen plano puro y orienta a erupción liquenoide por fármacos), el infiltrado profundo perianexial y la mucina dérmica (lupus), y los eosinófilos o plasmocitos (fármacos, mucosas).

A. Dermatitis liquenoides

Liquen plano (Lichen planus)

Clínica: Dermatitis frecuente ($\approx 1\%$), muy pruriginosa, simétrica y papuloescamosa; 4.^a-6.^a décadas, leve predominio femenino. Pápulas poligonales, planas, brillantes, violáceas ("las 4/6 P": pápula, placa, púrpura/violácea, poligonal, pruriginosa), con finas líneas blancas en la superficie (estrías de Wickham); cara flexora de muñecas y antebrazos, tobillos, región lumbar y glande. Fenómeno de Koebner positivo. Autolimitado (semanas a 1-2 años).

Afectación mucosa y ungueal: Mucosa oral hasta en el 60 % (patrón reticular blanco, a veces erosivo/atrófico; el liquen plano oral erosivo crónico tiene un riesgo bajo pero real de carcinoma escamoso). Afectación genital, esofágica y conjuntival posible. Uñas: adelgazamiento, estrías longitudinales y pterigion. Variantes: hipertrófico, atrófico, ampolloso, actínico, folicular (liquen planopilar), pigmentoso.

Histopatología: Infiltrado linfohistiocitario denso "en banda" en la dermis papilar que abraza la unión dermoepidérmica; hiperqueratosis ortoqueratósica (sin paraqueratosis), hipergranulosis "en cuña" (en V, sobre los acrosiringios/folículos), acantosis irregular con crestas en "dientes de sierra"; vacuolización de la basal con queratinocitos apoptóticos (cuerpos de Civatte/coloides) en la unión y dermis papilar; hendiduras de Max-Joseph (separación focal dermoepidérmica); melanófagos por incontinencia pigmentaria.

Inmunofluorescencia: IFD: cuerpos coloides que tiñen para IgM (y otras Ig) en agregados, y depósito de fibrinógeno "en harapos" (shaggy) a lo largo de la membrana basal.

Liquen nítido (Lichen nitidus)

Clínica: Pápulas diminutas (1-2 mm), del color de la piel o hipopigmentadas, brillantes, agrupadas, en abdomen, genitales y extremidades; más en niños y adultos jóvenes. Puede koebnerizar.

Histopatología: Infiltrado linfohistiocitario bien delimitado, focal, limitado a una o dos papilas dérmicas ensanchadas, "abrazado" por crestas epidérmicas elongadas a los lados (imagen "en garra abrazando una pelota", ball-in-claw); contiene histiocitos y a veces células gigantes; vacuolización basal suprayacente y adelgazamiento epidérmico con paraqueratosis focal.

Queratosis liquenoide (queratosis liquenoide benigna / liquen plano-like keratosis) (Lichenoid keratosis)

Clínica: Pápula o placa solitaria, a menudo en tórax o extremidades superiores de mujeres de edad media; representa una queratosis seborreica o un lentigo solar en regresión inflamatoria. Clínicamente se confunde con carcinoma basocelular o lesión melanocítica.

Histopatología: Infiltrado liquenoide tipo liquen plano con vacuolización basal y cuerpos apoptóticos, pero con frecuencia paraqueratosis y eosinófilos/plasmocitos, y restos de una queratosis seborreica o un lentigo solar en el borde de la lesión (pista clave).

Liquen estriado (Lichen striatus)

Clínica: Erupción lineal blaschkoide de pápulas pequeñas, en una extremidad de niños; autolimitada (meses), puede dejar hipopigmentación.

Histopatología: Infiltrado liquenoide focal y discontinuo con cambio de interfase, que además se extiende en profundidad alrededor de glándulas ecrinas y folículos (infiltrado perianexial profundo), rasgo útil; disqueratosis focal.

Blaschkitis del adulto (Adult Blaschkitis)

Clínica: Erupción papulovesiculosa pruriginosa que sigue las líneas de Blaschko en el tronco de adultos; brotes recurrentes (considerada por algunos el equivalente del liquen estriado en el adulto, más espongíotico).

Histopatología: Dermatitis espongíotica y/o liquenoide siguiendo un patrón blaschkoide.

Queratosis liquenoide crónica (de Nekam) (Keratosis lichenoides chronica)

Clínica: Pápulas queratósicas violáceas dispuestas de forma lineal y reticulada en extremidades, con dermatitis seborreica-like facial; curso crónico.

Histopatología: Patrón liquenoide con hiperqueratosis y paraqueratosis, atrofia epidérmica alternante e infiltrado en banda.

Erythema dyschromicum perstans (dermatosis cenicienta) (Erythema dyschromicum perstans)

Clínica: Máculas grisáceas ("cenicientas"), simétricas, en tronco y extremidades; más frecuente en fototipos oscuros (Latinoamérica). Curso crónico, a veces con borde eritematoso activo inicial.

Histopatología: Cambio de interfase vacuolar discreto con escaso infiltrado liquenoide y marcada incontinencia pigmentaria (numerosos melanófagos en la dermis papilar), que explica el color gris.

Dermatitis liquenoide y granulomatosa (Lichenoid and granulomatous dermatitis)

Concepto: Patrón que combina infiltrado liquenoide de interfase con granulomas dérmicos; diagnóstico diferencial amplio: reacciones a fármacos, infecciones (micobacterias, sífilis), liquen nítido, rosácea granulomatosa y dermatitis liquenoide granulomatosa idiopática. Exige correlación clínica y descartar infección.

B. Dermatosis de interfase

Se definen por el daño vacuolar de la basal con apoptosis de queratinocitos; el infiltrado puede ser escaso (patrón vacuolar). El espectro abarca desde el eritema multiforme hasta la necrólisis epidérmica tóxica, las poiquilodermias y varias genodermatosis con fotosensibilidad.

Eritema multiforme (Erythema multiforme)

Clínica: Erupción aguda, a menudo recurrente, de lesiones "en diana" típicas (tres zonas concéntricas) en superficies acrales y extensoras; desencadenante más frecuente: virus herpes simple (también Mycoplasma en niños). Puede haber afectación mucosa (eritema multiforme mayor). Se distingue clínicamente del espectro Stevens-Johnson/NET, que se asocia sobre todo a fármacos y a despegamiento extenso.

Histopatología: Cambio de interfase vacuolar con queratinocitos apoptóticos dispersos en todos los niveles de la epidermis (no solo basales), infiltrado linfocítico perivascular superficial y en la unión, exocitosis y edema de la dermis papilar; en lesiones avanzadas, necrosis confluyente de queratinocitos con ampolla subepidérmica. Escasa o nula afectación profunda.

Necrólisis epidérmica tóxica y síndrome de Stevens-Johnson (Toxic epidermal necrolysis and Stevens-Johnson syndrome)

Clínica: Espectro de reacción mucocutánea grave, casi siempre por fármacos (sulfamidas, anticonvulsivantes, alopurinol, AINE, nevirapina). Se clasifica por el porcentaje de despegamiento epidérmico: SJS <10 %, solapamiento 10-30 %, NET >30 %. Eritema doloroso, ampollas, despegamiento "en sábana", signo de Nikolsky positivo y afectación mucosa grave; alta mortalidad (relacionada con la superficie despegada).

Histopatología: Necrosis de queratinocitos que progresa a necrosis confluyente de todo el espesor de la epidermis con ampolla subepidérmica y techo necrótico; infiltrado dérmico característicamente escaso (desproporción entre el daño epidérmico masivo y el infiltrado escaso). La biopsia por congelación del techo permite un diagnóstico rápido.

Pénfigo paraneoplásico (Paraneoplastic pemphigus)

Nota: Se trata con detalle en el capítulo de trastornos acantolíticos. Aquí interesa por su componente de interfase: combina acantólisis suprabasal con dermatitis de interfase liquenoide y queratinocitos apoptóticos, en el contexto de una neoplasia (linfoproliferativa, Castleman). IFD: depósito intercelular y en la membrana basal; IFI positiva sobre epitelio de transición (vejiga de rata).

Poiquilodermias

La poiquiloderma es un patrón clínico-histológico que combina atrofia epidérmica, telangiectasias, hipo e hiperpigmentación moteada. Histológicamente: epidermis atrófica, cambio de interfase vacuolar, telangiectasias e incontinencia pigmentaria en la dermis papilar. Es un patrón común a varias entidades.

Poiquiloderma (concepto y causas) (Poikiloderma)

Causas: Dermatomiositis, lupus eritematoso, micosis fungoide (poiquiloderma atrófica vascular), poiquiloderma de Civatte, genodermatosis (Rothmund-Thomson, Bloom, Cockayne, disqueratosis congénita), radiodermatitis crónica y EICH crónico.

Histopatología: Atrofia epidérmica con rectificación de las crestas, vacuolización basal, dilatación de los vasos de la dermis papilar y melanófagos.

Poiquiloderma de Civatte (Poikiloderma of Civatte)

Clínica: Eritema reticulado con telangiectasias e hiperpigmentación moteada en zonas fotoexpuestas del cuello y escote, respetando la zona sombreada submentoniana; mujeres de edad media-avanzada, por daño solar crónico.

Histopatología: Poiquiloderma con elastosis solar.

Poiquilodermia asociada a síndromes de ADN mitocondrial (Mitochondrial DNA syndrome-associated poikiloderma)

Concepto: Poiquilodermia en el contexto de síndromes por deleciones del ADN mitocondrial (p. ej., con anemia sideroblástica). Rara.

Genodermatosis con cambio de interfase / fotosensibilidad y reparación del ADN

Síndrome de Rothmund-Thomson (Rothmund-Thomson syndrome)

Clínica: Poiquilodermia de inicio en la lactancia (mejillas, nalgas, extremidades), fotosensibilidad, cataratas juveniles, talla baja, anomalías esqueléticas y del pelo, y mayor riesgo de osteosarcoma y carcinoma cutáneo.

Genética: Mutaciones de RECQL4 (helicasa de reparación del ADN); autosómico recesivo.

Síndrome de Bloom (Bloom syndrome)

Clínica: Eritema telangiectásico facial fotosensible "en alas de mariposa", talla baja, facies característica, inmunodeficiencia y predisposición notable a neoplasias.

Genética: Mutaciones de BLM (helicasa RecQ); autosómico recesivo; inestabilidad cromosómica con intercambio elevado de cromátides hermanas.

Síndrome de Cockayne (Cockayne syndrome)

Clínica: Fotosensibilidad, facies de "duende" (caquética), enanismo, retraso mental, sordera, retinopatía y envejecimiento prematuro; sin el aumento de cáncer cutáneo del xeroderma pigmentoso.

Genética: Mutaciones de ERCC6 (CSB) o ERCC8 (CSA); defecto de reparación del ADN acoplada a la transcripción.

Disqueratosis congénita (Dyskeratosis congenita)

Clínica: Tríada: pigmentación reticulada (cuello, tronco), distrofia ungueal y leucoplasia mucosa; insuficiencia medular progresiva (principal causa de muerte) y predisposición a neoplasias.

Genética: Defectos del mantenimiento de los telómeros: DKC1 (disquerina, ligada al X), TERC, TERT y otros.

Histopatología: Cambios poiquilodérmicos inespecíficos; el diagnóstico es clínico-genético.

Enfermedad de injerto contra huésped (EICH) (Graft-versus-host disease)

Clínica: Tras trasplante alogénico (de progenitores hematopoyéticos) o, raramente, transfusiones. EICH aguda: exantema maculopapular (palmas, plantas, orejas, cara) que puede progresar a eritrodermia y despegamiento tipo NET; con afectación hepática y digestiva. EICH crónica: formas liquenoides (similares al liquen plano) y esclerodermiformes (similares a morfea/lichen escleroso).

Histopatología (aguda, graduación de Lerner): Grado 1: vacuolización basal aislada. Grado 2: vacuolización + queratinocitos apoptóticos disqueratóticos con linfocitos satélites adyacentes (satelitosis: "satellite cell necrosis"). Grado 3: hendiduras subepidérmicas focales. Grado 4: separación completa de la epidermis. EICH crónica liquenoide: infiltrado en banda con hipergranulosis y apoptosis; esclerodermiforme: esclerosis dérmica.

Pitiriasis liquenoide (Pityriasis lichenoides)

Clínica: Espectro: pitiriasis liquenoide y varioliforme aguda (PLEVA, enfermedad de Mucha-Habermann), con pápulas necróticas y costrosas en brotes; y pitiriasis liquenoide crónica (PLC), con pápulas pardas descamativas de evolución más lenta. Niños y adultos jóvenes. La forma febril ulceronecrotica es una variante grave.

Histopatología: PLEVA: dermatitis de interfase con paraqueratosis, exocitosis linfocitaria intensa, queratinocitos necróticos, extravasación de hematíes en la epidermis y la dermis, e infiltrado linfocítico en cuña que llega a la dermis reticular; puede haber vasculitis linfocítica. PLC: cambios más leves, paraqueratosis focal e infiltrado superficial. Los linfocitos son predominantemente CD8+; en algunos casos hay clonalidad T (relación discutida con la papulosis linfomatoide).

Tablas de alto rendimiento

Tabla — Patrón vacuolar vs liquenoide

Rasgo	Interfase vacuolar	Interfase liquenoide
Infiltrado	Escaso, perivascular	Denso, en banda
Apoptosis	Dispersa, a veces en todos los niveles	Basal (cuerpos de Civatte)
Ejemplos	Eritema multiforme, NET, EICH agudo, lupus agudo	Liquen plano, lupus crónico, fármacos liquenoides

Tabla — Liquen plano vs erupción liquenoide por fármacos vs lupus

Rasgo	Liquen plano	Liquenoide por fármacos	Lupus (DLE)
Paraqueratosis	Ausente	Presente (focal)	Presente
Eosinófilos / plasmocitos	Ausentes	Presentes	Variable / plasmocitos
Profundidad del infiltrado	Superficial en banda	Superficial y profundo	Superficial y profundo perianexial
Mucina dérmica	Ausente	Ausente	Presente
Apoptosis	Basal	En varios niveles	Basal + engrosamiento de la membrana basal
IFD	Cuerpos coloides IgM, fibrinógeno shaggy	Inespecífica	Banda lúpica (IgG/C3 granular)

Tabla — Eritema multiforme vs SJS/NET

Rasgo	Eritema multiforme	SJS / NET
Desencadenante	Virus herpes simple, Mycoplasma	Fármacos
Lesión típica	Diana típica acral	Máculas, despegamiento "en sábana"
Necrosis epidérmica	Focal / queratinocitos dispersos	Confluente de todo el espesor
Infiltrado	Moderado	Escaso (desproporcionado al daño)
Mortalidad	Baja	Alta (según superficie despegada)

Tabla — Graduación de la EICH aguda (Lerner)

Grado	Hallazgo histológico
1	Vacuolización de la capa basal
2	Vacuolización + queratinocitos apoptóticos con linfocitos satélites
3	Hendiduras subepidérmicas focales
4	Separación completa de la epidermis (tipo NET)

Glosario bilingüe (inglés → español)

Término (EN)	Español	Nota
Lichenoid infiltrate	Infiltrado liquenoide	Banda linfohistiocitaria en dermis papilar
Interface change	Cambio de interfase	Vacuolización basal ± apoptosis
Vacuolar (hydropic) degeneration	Degeneración vacuolar (hidrópica)	De las células basales
Civatte / colloid bodies	Cuerpos de Civatte / coloides	Queratinocitos apoptóticos
Wickham striae	Estrías de Wickham	Líneas blancas del liquen plano
Wedge-shaped hypergranulosis	Hipergranulosis en cuña	Sobre acrosiringios/folículos (LP)
Sawtooth rete ridges	Crestas en dientes de sierra	Liquen plano
Max-Joseph spaces	Espacios de Max-Joseph	Hendiduras dermoepidérmicas (LP)
Ball-in-claw	En garra abrazando una pelota	Liquen nítido
Pigment incontinence	Incontinencia pigmentaria	Melanófagos dérmicos
Satellite cell necrosis	Necrosis con células satélite	EICH (linfocito junto a queratinocito apoptótico)
Poikiloderma	Poiquilodermia	Atrofia + telangiectasias + pigmentación moteada
Shaggy fibrinogen	Fibrinógeno "en harapos"	IFD del liquen plano en la membrana basal
Full-thickness necrosis	Necrosis de todo el espesor	NET
Target lesion	Lesión en diana	Eritema multiforme

Nota: documento de elaboración propia con fines de estudio.